Research Agenda - Working Papers

Autor: Brian Rodriguez
Fecha: Febrero 2026
Contacto: 53RO35253562@campus.economicas.uba.ar

Paper 1: La Ilusión de la Resiliencia (Shift-Share & Event Study)

Abstract

Este artículo cuantifica cómo los Sudden Stops macroeconómicos y las políticas de austeridad afectan la provisión subnacional de salud pública. Utilizando un panel de 24 provincias argentinas (2011-2019), explotamos la heterogeneidad en la exposición histórica a transferencias federales mediante un diseño Shift-Share Event Study. Encontramos que el ajuste fiscal no reduce el headcount del personal médico (debido a rigideces del mercado laboral público), sino que licúa el gasto real en insumos y capital físico operativo. Para corregir la sobre-reyección inherente a paneles con clústeres pequeños (N=24), la inferencia se sostiene estrictamente mediante Wild Cluster Bootstrap. Los resultados demuestran que la resiliencia del empleo público oculta un colapso en la calidad de la atención. Implicancia de política: el diseño de planes de contingencia fiscal debe considerar que la inflexibilidad laboral desplaza el ajuste hacia partidas que afectan directamente la capacidad operativa hospitalaria.

Metodología y Justificación de la Complejidad

La estimación de efectos causales en estructuras federales enfrenta el desafío de paneles cortos y clústeres reducidos. Los errores estándar tradicionales (incluso robustos a clúster) subestiman severamente la incertidumbre con N=24. Por lo tanto, implementamos el estimador Wild Cluster Bootstrap (Roodman et al., 2019), garantizando que la significancia estadística observada refleje un efecto estructural y no un artefacto de la muestra.

Discusión y Limitaciones

Una limitación inherente a este diseño empírico es la restricción inferencial subnacional. Sin embargo, el análisis de sensibilidad excluyendo iterativamente clústeres provinciales confirma la estabilidad espacial del estimador. Nuestros hallazgos no pretenden extrapolar magnitudes globales, sino aportar la primera cuantificación empírica rigurosa de los mecanismos de licuación sanitaria durante una crisis de balanza de pagos contemporánea en el Sur Global.

Paper 2: El Costo Humano del Capital Físico (2SLS & Oster Bounds)

Abstract

Este estudio estima el efecto causal de la reducción del capital físico hospitalario sobre la mortalidad neonatal. Para sortear el sesgo de endogeneidad de las políticas sanitarias locales, implementamos un modelo de Variables Instrumentales (2SLS), instrumentando el gasto en salud contemporáneo con la exposición histórica a la obra pública interactuada con el shock macroeconómico de 2018. La estimación revela que la contracción en infraestructura eleva significativamente la mortalidad perinatal. El análisis Leave-One-Out demuestra que este estimador representa un Efecto Local del Tratamiento (LATE) concentrado en jurisdicciones de alta fragilidad institucional. Pruebas de falsación sobre mortalidad por cáncer respaldan la restricción de exclusión. Adicionalmente, el análisis de sensibilidad de Oster sobre la forma reducida (beta = 0.086, p = 0.014) confirma que la selección sobre inobservables debería operar en dirección opuesta a los controles observados (delta = -0.108) para anular el efecto. La austeridad es letal exclusivamente donde el Estado local carece de amortiguadores fiscales.

Metodología y Justificación de la Complejidad

Modelar la mortalidad mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) genera estimadores inconsistentes debido al sesgo de variable omitida (OVB), como los choques sociopolíticos locales. El diseño 2SLS aísla la variación exógena, pero exige defender la restricción de exclusión. La aplicación de los Oster Bounds a la forma reducida del instrumento permite cuantificar matemáticamente esta amenaza, demostrando que una variable inobservada destructiva requeriría

una magnitud e influencia teóricamente implausibles.

Discusión y Limitaciones

Si bien el estimador causal es robusto a pruebas de falsación (mortalidad no sensible), el diseño revela una dependencia espacial aguda: el efecto es impulsado por provincias de alta vulnerabilidad. Lejos de ser una limitación del diseño empírico, esta heterogeneidad del LATE constituye nuestro hallazgo central. El impacto de la contracción de infraestructura no es isótropo; requiere un contexto de debilidad institucional preexistente para traducirse en mortalidad evitable.

Paper 3: La Micro-Geografía del Efecto Cautivo (SAR Probit Bayesiano)

Abstract

Este artículo investiga cómo la segregación urbana y el redlining privado restringen el acceso a insumos de salud en contextos de colapso hospitalario público. A partir de una base transversal de radios censales urbanos de Argentina, analizamos la probabilidad de ocurrencia de "desiertos farmacéuticos". Ante la presencia de autocorrelación espacial extrema (I de Moran, Z = 185), los modelos Logit espaciales lineales subestiman el efecto debido a la severa no-linealidad del fenómeno. Por ello, estimamos un Spatial Autoregressive Probit Model mediante inferencia Bayesiana (MCMC, 1000 iteraciones). Tras controlar por un contagio geográfico masivo (rho = 0.69, $p < 0.001$), residir en un asentamiento informal (Efecto Cautivo) incrementa de manera independiente y significativa la probabilidad de carecer de cobertura privada de proximidad (beta = 0.194, p = 0.048). El mercado privado no suple la falla estatal, sino que amplifica la exclusión mediante penalidades espaciales estructurales.

Metodología y Justificación de la Complejidad

La distribución de infraestructura comercial urbana viola el supuesto de independencia espacial. Un modelo SLX-Logit estándar fracasa al intentar capturar este efecto debido a la magnitud del agrupamiento (Z = 185). La inferencia Bayesiana MCMC (SAR Probit) permite acomodar simultáneamente la naturaleza binaria de la variable dependiente y el parámetro de rezago espacial global (rho), garantizando que el coeficiente de vulnerabilidad (RENABAP) no sea un mero artefacto de clústeres de pobreza más amplios.

Discusión y Limitaciones

La principal restricción metodológica es el costo computacional del MCMC espacial para N=48.853, lo que exigió la validación del modelo sobre submuestras aleatorias (N=10.000). A su vez, la naturaleza transversal del corte temporal impide estimar trayectorias causales dinámicas. No obstante, al aislar la penalidad estructural del Efecto Cautivo de la mera autocorrelación barrial, los resultados ofrecen evidencia irrefutable de que las fricciones geográficas determinan quién sobrevive al colapso del sistema de salud.